새 약 뒤 발진,
언제 바로 진료받아야 할까요?

약을 먹은 시점과 발진 이외의 증상을 함께 봅니다. 늦게 생긴 발진도 약물 반응일 수 있습니다.

시간이 다르더라도 놓치지 않을 신호



아나필락시스는 대개 30분 이내, SJS/TEN은 4~30일, DRESS는 2~8주 뒤 나타날 수 있습니다.

다음 증상은 바로 진료로 이어갑니다

함께 나타나는 증상	필요한 행동
두드러기·부종 + 숨참, 혈압 저하 또는 의식 소실	**즉시 응급실 처치**가 필요한 아나필락시스 신호입니다.
약 복용 + 발열 + 넓게 퍼지는 발진	중증 약물 반응을 의심해 **즉시 진료·상급기관 평가**를 받습니다.
피부가 벗겨짐, 입·눈·생식기 점막 병변	SJS/TEN을 의심하는 신호입니다. 지체하지 말고 진료받습니다.

약을 끊었다고 안심하지 마세요

DRESS: 피부와 장기를 함께 보는 반응

발열·발진과 함께 간 등 내부 장기가 영향을 받을 수 있습니다. 얼굴 부종이나 림프절 변화가 동반될 수 있고, **원인 약물을 중단한 뒤에도 악화**할 수 있습니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

진료 때는 약의 이름과 시작한 날짜를 알려주세요

처방약뿐 아니라 한약·민간요법·건강보조식품·피부나 점막에 바른 약까지 포함합니다.

중증 반응은 이렇게 평가합니다

반응	강의에서 설명한 특징·진료
DRESS **약물 과민증후군**	대개 투여 **2~8주** 뒤 발열·발진·장기 침범. 간 침범이 가장 흔합니다. 혈액·간기능·신기능 검사를 합니다.
SJS/TEN **심한 피부·점막 반응**	대개 투여 **4~30일** 뒤 발생. 점막 침범 약 **90%**, 안과 합병증 **20~70%**로 안과 협진이 중요합니다.
아나필락시스 **급격한 전신 반응**	대개 투여 **30분 이내** 발생. 피부·호흡·혈압·위장관·의식에 영향을 줄 수 있습니다. 의료진이 에피네프린 근육주사로 응급 치료합니다.

피부가 벗겨지는 넓이는 의료진이 평가합니다

SJS와 TEN은 같은 범위의 중증 반응입니다

벗겨진 면적이 체표면적의 **<10%**이면 SJS, **10~30%**는 중첩, **>30%**는 TEN으로 분류합니다. TEN은 사망률이 높아 집중 치료가 필요할 수 있습니다. 이 면적을 스스로 재느라 진료를 늦추지 마세요.

약과 증상의 시간표를 준비하세요

1. 약 이름·시작일과 중단일, 발진이 시작된 날을 정리합니다.
2. 발진 위치·퍼지는 속도·재발 여부와 발열·숨참 등 피부 밖 증상도 알립니다.
3. 항경련제, 알로푸리놀, 설폰아마이드 등은 강의에 소개된 원인 약물입니다. 복용 약 전체를 의료진에게 보여주세요.
4. 의심되는 원인 약물의 즉시 중단은 치료의 핵심입니다. 의료진에게 약 목록을 보여 원인 약물을 판단받습니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/dermatology/drug-rash-warning-asan28/